

Guia 01 — Agente comunitário de saúde

Mestre de trabalho controlado em português brasileiro — versão 1.1-rascunho

Data de revisão: 5 de agosto de 2026 **Público:** Pessoas adultas que exploram caminhos de entrada, transição ou progressão no trabalho comunitário em saúde

Status: Mestre substantivo em português brasileiro concluído a partir do mestre controlado em inglês e do registro terminológico trilingue. A integração trilingue, a revisão editorial frase por frase, a revisão de paridade estrutural e segurança, a normalização terminológica, a reconciliação das estimativas de renda e a revisão controlada de links estão registradas. O congelamento editorial e terminológico trilingue está concluído. Ainda estão pendentes a validação final de links ativos e estimativas de mercado datadas, a geração de DOCX/PDF, metadados, checksums, renderização e QA de publicação.

Este guia oferece informações gerais sobre carreira e educação. Os requisitos variam conforme o país, estado, província, território, empregador, programa de financiamento e título do cargo. Ele não oferece aconselhamento médico, jurídico, migratório, de licenciamento, acreditação ou financeiro. A conclusão de curso, certificado, estágio, aprendizagem formal ou serviço voluntário não garante emprego, certificação, registro, licença, promoção ou renda.

1. O que faz um agente comunitário de saúde

Um agente comunitário de saúde ajuda pessoas a se conectarem com serviços de saúde, programas de saúde pública, assistência social e recursos práticos da comunidade. A função se baseia em confiança, compreensão cultural, comunicação e conhecimento da comunidade atendida.

Títulos comuns incluem:

- agente comunitário de saúde;
- promotor ou promotora de saúde;
- navegador de pares;
- navegador de pacientes;
- profissional de alcance comunitário;
- representante comunitário de saúde;
- orientador comunitário de saúde;
- educador ou orientador de saúde;
- profissional de apoio familiar ou comunitário.

Os títulos não são uniformes. Dois empregadores podem usar o mesmo título para funções diferentes, e duas pessoas podem executar tarefas semelhantes com títulos distintos. Leia sempre a descrição da vaga e confirme os requisitos locais.

As responsabilidades típicas podem incluir:

- explicar informações de saúde e de assistência social em linguagem simples;
- ajudar pessoas a marcar consultas e compreender encaminhamentos;
- conectar indivíduos e famílias a transporte, alimentação, moradia, benefícios ou apoio linguístico;
- apoiar prevenção, triagem, educação sobre doenças crônicas e acompanhamento dentro de um programa autorizado;
- realizar ações de aproximação e atendimento comunitário em residências, escolas, clínicas, comunidades religiosas, abrigos, locais de trabalho ou eventos comunitários;
- documentar serviços e resultados;
- identificar barreiras relacionadas aos determinantes sociais da saúde;
- fortalecer a confiança entre comunidades e organizações de saúde ou assistência social;
- encaminhar preocupações urgentes, clínicas, de proteção ou privacidade a profissionais qualificados.

Um agente comunitário de saúde não é automaticamente enfermeiro, médico, psicólogo, assistente social, terapeuta ou outro profissional clínico licenciado. Deve atuar dentro das funções autorizadas pelo empregador, programa, treinamento, supervisão e legislação local.

2. Quem pode ter um bom perfil para esse trabalho

O trabalho comunitário em saúde pode ser adequado para pessoas pacientes, confiáveis, culturalmente respeitosas e confortáveis ao ajudar outras pessoas a navegar sistemas complexos. Experiência de vida, credibilidade na comunidade, capacidade bilíngue e conhecimento de recursos locais podem ser grandes pontos fortes.

Qualidades úteis incluem:

- escuta ativa e empatia;
- comunicação oral e escrita clara;
- respeito à privacidade e à escolha informada;
- confiabilidade e registros precisos;
- capacidade de reduzir tensões e lidar com conflitos com segurança;
- humildade cultural;
- habilidades digitais básicas;

- disposição para trabalhar com equipes multidisciplinares;
- capacidade de manter limites profissionais;
- disponibilidade para deslocamentos locais ou trabalho fora de um escritório tradicional.

O trabalho pode ser emocionalmente exigente. Os empregadores devem oferecer supervisão, procedimentos de segurança, procedimentos claros para encaminhar situações que excedam as atribuições do trabalhador e apoio para casos difíceis.

3. Educação, formação e credenciais

Não existe uma única qualificação mundial para essa ocupação. Os requisitos variam conforme a jurisdição e o empregador.

Estados Unidos

O Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos identifica o ensino médio completo ou equivalente como a escolaridade típica de entrada e o treinamento de curta duração oferecido no local de trabalho como preparação usual. Esse perfil nacional não substitui regras estaduais de certificação nem requisitos específicos dos empregadores.

Alguns estados possuem certificação formal, programas de treinamento aprovados, padrões de competência, registros ou exigências ligadas ao Medicaid. Outros dependem mais do treinamento do empregador ou de credenciais voluntárias. Antes de se matricular, verifique:

1. se o programa é reconhecido pelo estado ou pelo empregador visado;
2. se há exigência de experiência de campo supervisionada;
3. se são aplicáveis verificação de antecedentes, imunizações, habilitação para dirigir, idioma ou tecnologia;
4. se a credencial é voluntária, específica do empregador, reconhecida pelo estado ou necessária para reembolso de serviços.

Canadá

O Job Bank do Governo do Canadá associa o título “community health worker” ao **NOC 42201, trabalhadores de serviços sociais e comunitários**, um grupo ocupacional mais amplo do que a categoria dos Estados Unidos. O Job Bank informa que normalmente é exigido um programa universitário ou técnico em serviço social, atendimento a crianças e jovens, psicologia ou outra área relacionada às ciências sociais ou à saúde, embora experiência relevante de voluntariado ou apoio possa substituir a educação formal em algumas funções.

Os requisitos variam por província, território, autoridade de saúde, organização indígena e empregador. Enfermagem comunitária é uma

profissão regulada distinta e não deve ser confundida com funções de agente comunitário de saúde ou apoio comunitário.

Colômbia

Possíveis caminhos incluem trabalho com:

- Empresas Promotoras de Salud (EPS);
- Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS);
- Empresas Sociales del Estado (ESE);
- secretarias municipais ou departamentais de saúde;
- universidades e projetos de saúde pública;
- organizações não governamentais;
- organizações comunitárias;
- programas humanitários ou de desenvolvimento social.

As rotas integrais de atenção e as políticas de participação social em saúde da Colômbia incluem ações comunitárias e intersetoriais. Os requisitos dependem do empregador, contrato, programa, autoridade territorial e funções atribuídas. A autorização de uma organização comunitária não cria automaticamente uma licença profissional individual para cada trabalhador.

O SENA, as autoridades territoriais de saúde, universidades, empregadores e organizações comunitárias reconhecidas são locais apropriados para consultar formações atuais e caminhos de aprendizagem baseada no trabalho.

Outros países da América Latina

Funções comunitárias de saúde podem existir em ministérios da saúde, programas municipais, redes de atenção primária, ONGs, universidades, organizações humanitárias ou projetos financiados por doadores. Títulos como *promotor de salud*, *agente comunitário de saúde*, *facilitador comunitário* e *navegador de pacientes* podem não ser equivalentes entre países.

Verifique:

- a situação jurídica e institucional da função;
- se o trabalho é emprego remunerado, contrato de prestação de serviços, voluntariado ou projeto com bolsa ou ajuda de custo;
- se é exigida credencial em saúde, serviço social, formação técnica ou desenvolvimento comunitário;
- se existem requisitos de idioma local, idioma indígena, habilitação para dirigir, residência ou trabalho de campo.

4. Primeiro, aprendizagem gratuita e de baixo custo

Antes de pagar por um programa privado, use recursos oficiais gratuitos para confirmar se a ocupação corresponde aos seus objetivos.

Recursos dos Estados Unidos

- **Recursos dos CDC para agentes comunitários de saúde:** informações sobre a função, ferramentas e recursos de saúde pública.
<https://www.cdc.gov/chronic-disease/php/community-health-worker-resources/index.html>
- **Recurso de treinamento cardiovascular dos CDC:** material gratuito para profissionais com alguma experiência; não substitui treinamento básico nem constitui credencial universal.
https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/dhdsp/programs/spha/chw_training/index.htm
- **American Job Centers:** orientação profissional local, elegibilidade para treinamento e conexão com empregadores.
<https://www.careeronestop.org/LocalHelp/AmericanJobCenters/american-job-centers.aspx>
- Departamentos estaduais de saúde, associações estaduais de agentes comunitários, *community colleges*, centros de saúde qualificados federalmente e departamentos de saúde pública podem divulgar programas aprovados ou vinculados a empregadores.

Recursos do Canadá

Consulte:

- serviços provinciais ou territoriais de emprego;
- instituições públicas de ensino superior;
- autoridades de saúde;
- organizações indígenas de saúde;
- organizações de integração e serviços comunitários;
- treinamento patrocinado por empregadores.

Comece pelas páginas ocupacionais do Job Bank do Governo do Canadá e depois confirme os requisitos regionais.

Recursos da Colômbia

Consulte:

- cursos e serviços de emprego do SENA;
- Servicio Público de Empleo;
- secretarias territoriais de saúde;
- páginas de vagas e treinamento de EPS, IPS e ESE;
- universidades públicas;

- ONGs e organizações comunitárias reconhecidas.

Não presuma que todo curso on-line de curta duração seja reconhecido por empregadores ou autoridades.

5. Financiamento, bolsas e apoio do empregador

O financiamento depende de elegibilidade e muda com frequência. Solicite os termos por escrito antes de se matricular.

Possíveis formas de apoio incluem:

- fundos públicos para qualificação profissional;
- subsídios ou isenção de mensalidade em instituições públicas;
- integração, treinamento ou certificação pagos pelo empregador;
- reembolso educacional;
- bolsas de sistemas de saúde, fundações, sindicatos ou organizações comunitárias;
- estágios, programas de trainee, aprendizagens formais ou serviços remunerados;
- apoio para transporte, cuidados infantis, equipamentos ou exames;
- bolsas ou ajudas de custo por participação em projetos.

Mantenha as categorias separadas:

- **salário:** pagamento por emprego;
- **bolsa ou ajuda de custo:** apoio fixo que pode não criar vínculo empregatício;
- **bolsa de estudos ou subsídio:** financiamento educacional que pode ter condições;
- **empréstimo:** dinheiro que normalmente deve ser devolvido;
- **reembolso:** pagamento posterior de uma despesa aprovada;
- **aprendizagem profissional formal remunerada:** trabalho remunerado estruturado e instrução relacionada quando há programa formalmente estabelecido;
- **certificado de conclusão:** evidência de conclusão de um curso, não equivalendo automaticamente a licença profissional ou diploma acadêmico.

Nunca pague a um recrutador por uma oferta de emprego. Desconfie de programas que garantem emprego, certificação, resultado migratório ou renda incomumente alta.

6. Aprendizagens e formação remunerada no trabalho

Existem aprendizagens formais para agentes comunitários de saúde em algumas regiões dos Estados Unidos, mas a disponibilidade é regional.

Pesquise no localizador oficial do Apprenticeship.gov e confirme patrocinador, ocupação, local, remuneração, elegibilidade e instrução relacionada.

<https://www.apprenticeship.gov/apprenticeship-job-finder>

Outras opções legítimas de aprendizagem baseada no trabalho podem incluir:

- cargos de treinamento pagos pelo empregador;
- estágios em saúde pública;
- colocações em serviços comunitários;
- prática supervisionada;
- trajetórias profissionais de sindicatos ou sistemas de saúde;
- projetos remunerados de pesquisa ou alcance comunitário.

No Canadá e na América Latina, o termo “aprendizagem” pode não ser usado para esses caminhos. Procure estágios supervisionados, programas de trainee, práticas, treinamento do empregador ou cargos remunerados em programas comunitários, e confirme se o acordo cria condição de empregado, estudante, contratado, voluntário ou bolsista.

7. Renda e perspectivas de emprego

Os valores de renda são referências, não promessas.

Dados oficiais dos Estados Unidos

O *Occupational Outlook Handbook* do Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, modificado pela última vez em 28 de agosto de 2025, informa para Community Health Workers:

- salário anual mediano em maio de 2024: **USD 51.030**;
- salário horário mediano: **USD 24,54**;
- emprego em 2024: **65.100 postos**;
- crescimento projetado de 2024 a 2034: **11%**, muito mais rápido que a média;
- aproximadamente **7.800 vagas por ano** em média, conforme a projeção narrativa.

Fonte: <https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/community-health-workers.htm>

A remuneração varia por estado, região metropolitana, empregador, jornada, cobertura sindical, funções, idiomas, experiência e requisitos de certificação. A mediana não é um salário inicial.

Estimativas complementares do mercado dos Estados Unidos

As estimativas não governamentais atuais oferecem contexto adicional, mas não são estatísticas oficiais e não devem substituir os dados do Bureau of Labor Statistics apresentados acima. A Glassdoor exibiu **remuneração total mediana estimada de USD 52.000** para agentes comunitários de saúde nos Estados Unidos, com faixa típica de remuneração total de aproximadamente **USD 44.000 a USD 63.000**, na revalidação de 6 de agosto de 2026. A ZipRecruiter informou remuneração média anual estimada de **USD 44.925** em 27 de julho de 2026, utilizando anúncios de vagas de empregadores e dados de terceiros.

Essas estimativas usam métodos, amostras e ciclos de atualização diferentes. Não faça uma média entre elas, não as trate como ofertas garantidas e não presuma que se apliquem a um estado, empregador, nível de experiência ou modalidade de trabalho específicos.

Dados oficiais do Canadá

A tabela salarial nacional do Job Bank do Governo do Canadá para o NOC 42201, atualizada em 19 de novembro de 2025 e exibida em uma página modificada em 2 de junho de 2026, informa:

- nível baixo: **CAD 19,00 por hora;**
- mediana: **CAD 26,00 por hora;**
- nível alto: **CAD 36,06 por hora;**
- **83,6%** recebem pelo menos um benefício não salarial.

Fonte:

<https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/296075/ca>

Esses valores abrangem o grupo mais amplo NOC 42201. Eles não garantem ofertas específicas para agentes comunitários de saúde. Consulte a província, território e região aplicáveis.

Colômbia e América Latina

Neste lote, não foi verificada uma série salarial colombiana diretamente equivalente à ocupação do Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos. Não converta salários dos Estados Unidos ou do Canadá em expectativas salariais colombianas.

Para uma estimativa local, identifique o empregador exato, local, tipo de contrato, jornada, funções e escolaridade exigida. Dê maior peso a:

1. tabelas salariais oficiais do setor público;
2. vagas de empregadores com remuneração divulgada;
3. fontes reconhecidas do mercado de trabalho;

4. estimativas de mercado claramente identificadas, com geografia e limitações de amostra.

Mantenha salários separados de voluntariado, bolsas, pagamentos por projeto, subsídios e reembolsos.

8. Como desenvolver experiência de forma ética

Um portfólio inicial pode demonstrar habilidades de comunicação, orientação e conhecimento de recursos comunitários sem expor informações privadas.

Exemplos seguros incluem:

- um diretório de recursos públicos com links oficiais;
- um folheto de orientação em saúde, escrito em linguagem simples e conferido com uma fonte oficial;
- um plano simulado de alcance comunitário usando pessoas e organizações fictícias;
- um glossário bilíngue de termos não clínicos de orientação;
- um diagrama de fluxo de encaminhamento sem dados reais de pacientes;
- uma reflexão sobre humildade cultural, limites profissionais e escalonamento.

Não inclua nomes, históricos médicos, endereços, fotografias, números de identificação, detalhes de consultas, anotações de casos ou outras informações identificáveis de pessoas reais.

9. Uso responsável de inteligência artificial

A inteligência artificial pode ajudar a organizar informações públicas, melhorar a legibilidade, traduzir um rascunho para revisão posterior ou gerar cenários de prática. Ela não deve substituir julgamento profissional, políticas locais, aconselhamento clínico, controles de privacidade ou tradução qualificada quando a precisão for crítica.

Use estas salvaguardas:

- nunca insira informações pessoais de pacientes, clientes, candidatos, empregados ou membros da comunidade em um serviço de IA não aprovado;
- confirme informações de saúde e benefícios em fontes oficiais atuais;
- divulgue o uso de IA quando exigido pelo empregador, escola, financiador ou política de publicação;
- peça a revisores qualificados que verifiquem material traduzido ou clinicamente sensível;

- não use IA para diagnosticar, prescrever, determinar elegibilidade ou tomar decisões de emergência;
- siga os sistemas aprovados pelo empregador e as regras de retenção de dados.

10. Lista de verificação para busca de emprego

Antes de se candidatar:

1. Confirme o título exato e as funções.
2. Verifique se são exigidos certificação, registro, escolaridade, habilitação para dirigir, verificação de antecedentes, imunização, idioma ou viagens.
3. Confirme se a oportunidade é emprego, contrato, trabalho temporário, voluntariado, estágio, aprendizagem formal ou função com bolsa.
4. Compare corretamente o período de remuneração: por hora, mês, ano, visita ou projeto.
5. Pergunte sobre supervisão, segurança, volume de casos, reembolso de deslocamento, tecnologia, documentação e jornada.
6. Adapte o currículo com honestidade, destacando conhecimento da comunidade, orientação, alcance, idiomas, documentação e construção de confiança.
7. Nunca declare autoridade clínica ou credenciais que você não possui.

11. Plano de ação para os primeiros 30 dias

Semana 1 — Explorar

- Leia as páginas ocupacionais dos CDC e do BLS ou as fontes oficiais do seu país.
- Analise dez descrições atuais de vagas locais.
- Liste requisitos e títulos recorrentes.

Semana 2 — Construir fundamentos

- Conclua um recurso oficial gratuito de aprendizagem.
- Crie um diretório local de recursos.
- Pratique explicação em linguagem simples e documentação de encaminhamentos.

Semana 3 — Confirmar caminhos

- Entre em contato com um centro de emprego, instituição pública, escritório do SENA, autoridade de saúde, associação profissional ou empregador.
- Pergunte quais programas são realmente reconhecidos pelos empregadores.
- Compare financiamento, experiência de campo, horários e custo total.

Semana 4 — Candidatar-se com cuidado

- Prepare um currículo verdadeiro e uma mensagem de apresentação curta.
- Candidate-se a funções realistas de trainee, alcance, navegação ou agente comunitário de saúde.
- Registre candidaturas, acompanhamentos, requisitos e resultados.

12. Registro controlado de fontes

- Centers for Disease Control and Prevention, Resources for Community Health Workers, página datada de 3 de dezembro de 2024: <https://www.cdc.gov/chronic-disease/php/community-health-worker-resources/index.html>
- Recurso arquivado dos CDC para treinamento cardiovascular de agentes comunitários de saúde, revisado em 27 de abril de 2022: https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/dhdsp/programs/spha/chw_training/index.htm
- U.S. Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook, Community Health Workers, modificado em 28 de agosto de 2025: <https://www.bls.gov/ooh/community-and-social-service/community-health-workers.htm>
- Glassdoor, estimativa salarial para agentes comunitários de saúde nos Estados Unidos, consultada em 6 de agosto de 2026; remuneração total mediana estimada de USD 52.000 e faixa típica aproximada de USD 44.000–63.000: https://www.glassdoor.com/Salaries/community-health-worker-salary-SRCH_KO0,23.htm
- ZipRecruiter, estimativa salarial para agentes comunitários de saúde nos Estados Unidos, datada de 27 de julho de 2026; média estimada de USD 44.925 com base em anúncios de empregadores e dados de terceiros: <https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Community-Health-Worker-Salary>
- Government of Canada Job Bank, resumo e requisitos para Community Health Worker, modificado em 2 de junho de 2026: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/summary-occupation/296075/ca> e <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/requirements/296075/ca>
- Government of Canada Job Bank, relatório salarial, modificado em 2 de junho de 2026: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/296075/ca>
- Ministerio de Salud y Protección Social, Rutas Integrales de Atención en Salud: <https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/ssr/Paginas/Rutas-integrales-de-atencion-en-salud-RIAS.aspx>
- Ministerio de Salud y Protección Social, Política de Participación Social en Salud, base normativa Resolução 2063 de 2017:

13. Status de QA e revisão

Concluído para este mestre de trabalho:

- integração de fontes oficiais;
- controles de escopo ocupacional;
- caminhos nos Estados Unidos, Canadá, América Latina e Colômbia;
- orientação sobre financiamento e aprendizagem gratuita primeiro;
- controles sobre aprendizagem formal e formação no trabalho;
- dados oficiais controlados de renda dos Estados Unidos e do Canadá;
- salvaguardas de privacidade e uso responsável de IA;
- estrutura em linguagem simples e títulos orientados à acessibilidade;
- limitações explícitas sobre alegações de certificação e emprego;
- localização linguística em português brasileiro sob o registro terminológico trilingue.

Ainda necessário antes da publicação:

- validar todos os links externos no ambiente final do candidato;
- revalidar as estimativas complementares não governamentais imediatamente antes da publicação e manter suas limitações metodológicas;
- gerar candidatos DOCX e PDF pesquisáveis;
- verificar OOXML, hiperlinks, texto dos PDFs, metadados, renderização de páginas, nomes de arquivos, checksums e manifestos de publicação;
- não descrever revisão automatizada como certificação humana independente, certificação profissional de tradução, revisão de acreditação, certificação de acessibilidade ou revisão jurídica.